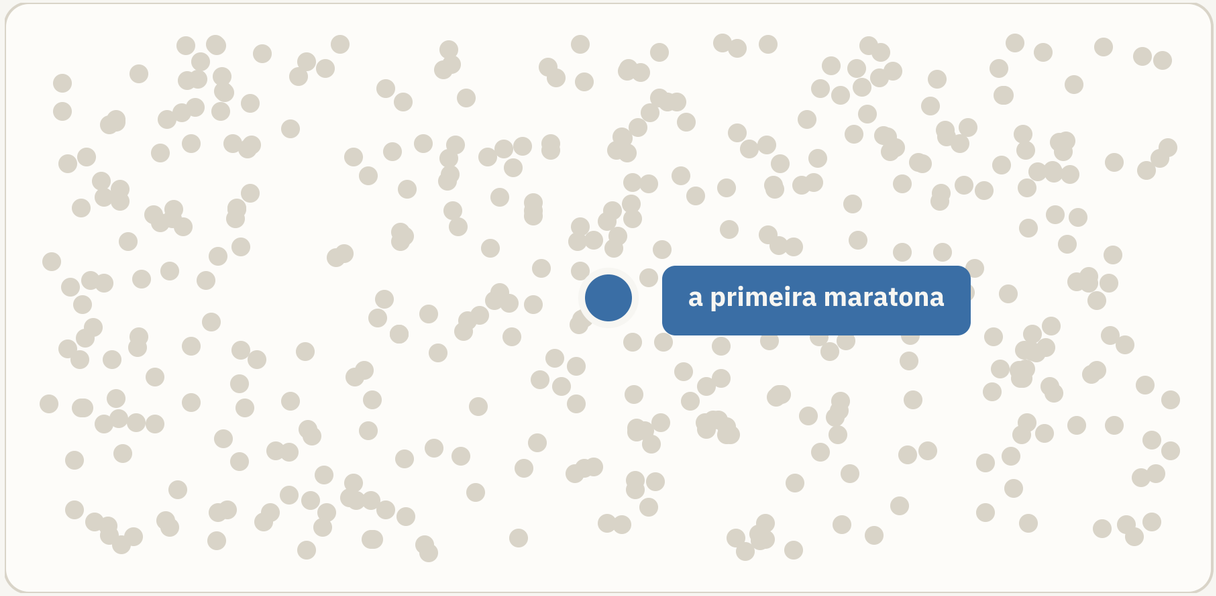
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Eventos de massa: risco cardiovascular em corrida de rua

O que os registros de provas mostram

O Atleta Amador e o Praticante Recreacional

Na maratona, cerca de uma parada a cada cem mil corredores



notícia do ano passado

“Corredor morre na maratona da cidade”

cerca de 1 em 100 mil

maratonistas tem uma parada cardíaca na prova

JAMA 2025

A PRIMEIRA DÉCADA MEDIDA, REGISTRO DE 2012

Sete em cada dez paradas foram fatais

10,9 milhões
corredores, 2000 a 2010

59
paradas cardíacas

0,54
por 100 mil corredores

71%
das paradas foram fatais



51 homens

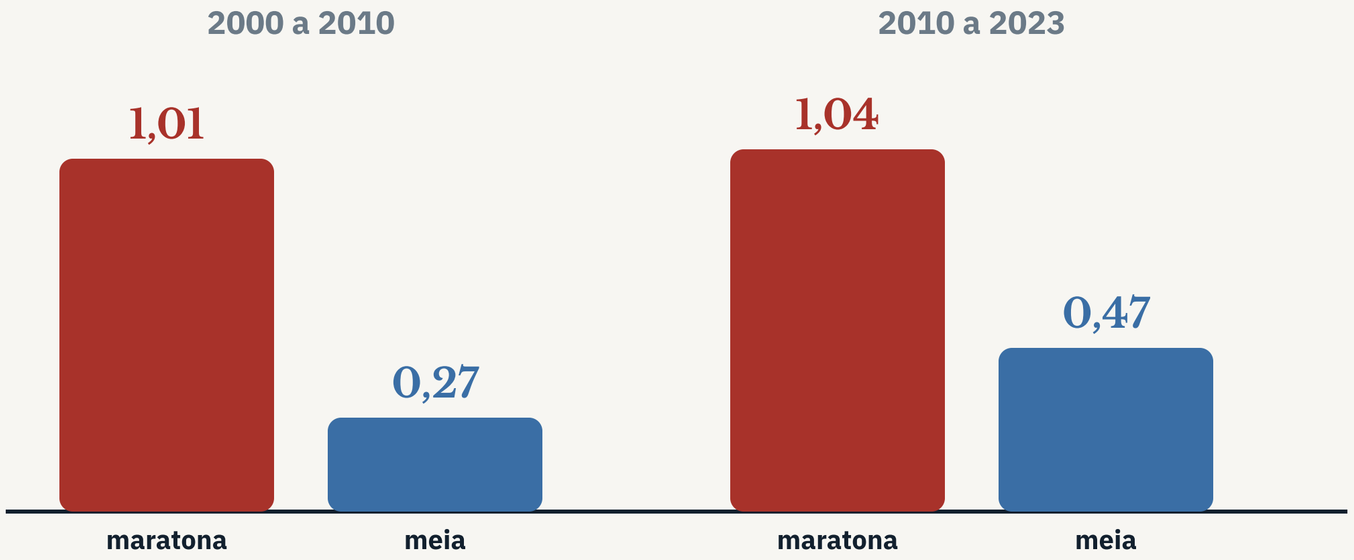
8 mulheres

idade média: 42 anos

N Engl J Med 2012

PARADAS POR 100 MIL CORREDORES

A maratona tem de duas a quatro vezes o risco da meia



homens na maratona, 2000 a 2010

0,71 → 2,03

primeira metade → segunda metade

o registro descreveu o aumento, sem testar a causa

N Engl J Med 2012 · JAMA 2025

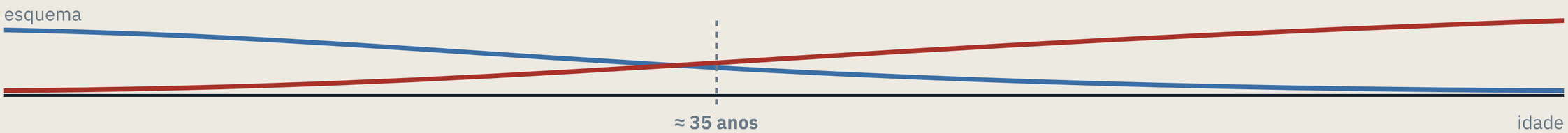
A prova revela a doença que estava escondida

Miocardiopatia hipertrófica

doença do músculo do coração, estrutural; pesa mais abaixo dos 35

Doença coronariana

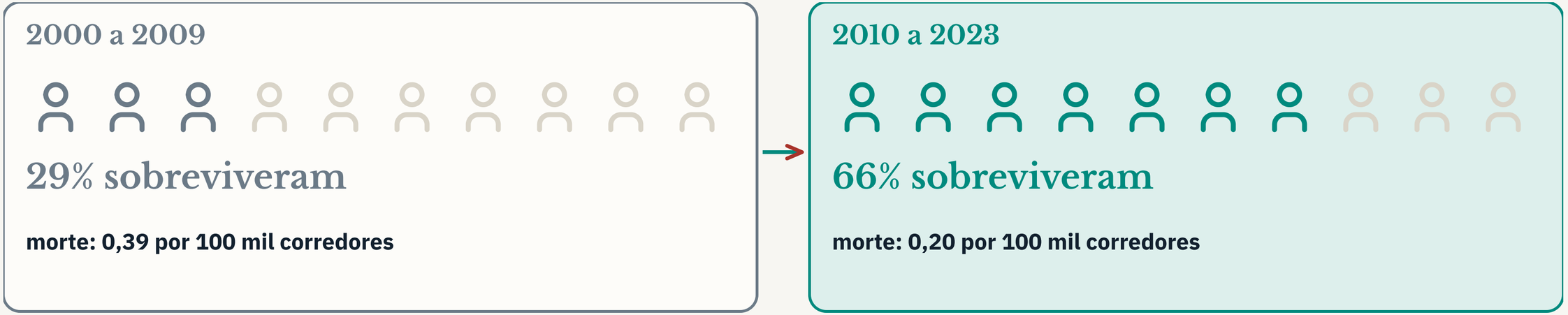
placa silenciosa; domina acima dos 35, e foi a mais comum no registro recente



A prova não cria a doença: é o dia em que a placa encontra o esforço mais longo do ano.

O REGISTRO ATUALIZADO EM 2025

A chance de sobreviver mais que dobrou



incidência: 0,54 → 0,60 por 100 mil · 176 paradas em 29,3 milhões de concluintes

A incidência não mudou. A morte caiu pela metade.

N Engl J Med 2012 · JAMA 2025

POR QUE A MORTE CAIU

Reanimação e desfibrilador, não exame em todos os inscritos

Registro de 2012: o que se associou à sobrevida

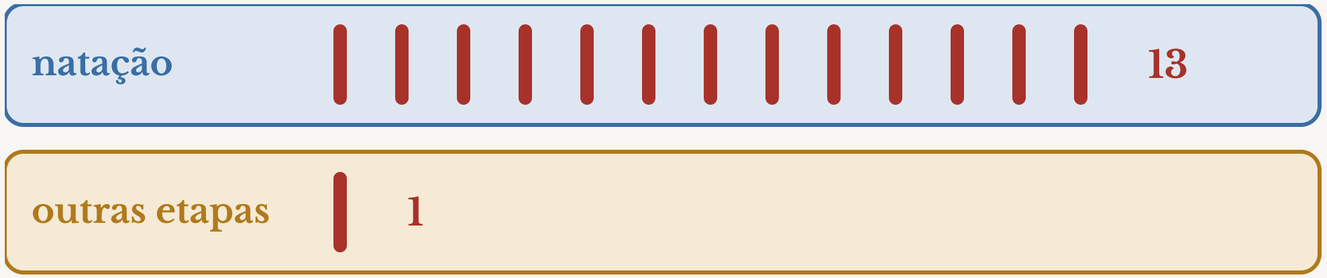
- **reanimação começada por quem estava perto**
- **causa diferente de miocardiopatia hipertrófica**

Registro de 2025: a resposta nas provas

- **reanimação em praticamente todos**
- **desfibrilador usado em quase todos**

O que mudou foi a resposta, não o rastreio.

No triatlo, quase todas as mortes foram na natação



registro com outra metodologia: a comparação com a corrida é aproximada

1,5 por 100 mil

14 mortes em cerca de 959 mil participantes, 2006 a 2008

80% homens · 28 a 65 anos

na água, quem perde a consciência afunda e não é visto a tempo

JAMA 2010

Pode largar; e quem organiza mede o tempo até o socorro



Para o corredor

- risco pequeno: largar, não desistir
- treinar para a distância
- sintoma no treino vai para a consulta, não para a prova
- febre ou infecção recente: não larga
- aprender reanimação



Para quem organiza

o número que importa

tempo até a reanimação e até o desfibrilador

não quantos inscritos fizeram exame

EVENTOS DE MASSA: CORRIDA DE RUA

O risco é pequeno, e o que o reduz é a resposta

- Cerca de uma parada a cada cem mil maratonistas, mais em homens de meia-idade
- A incidência não mudou; a morte caiu pela metade com reanimação e desfibrilador
- No triatlo, o ponto crítico é a natação

Medicina

Dá o número verdadeiro e investiga o sintoma do treino antes da largada.

Quem treina

Prepara para a distância e não deixa largar quem está doente.

O corredor

Aprende reanimação: na prova, quem salva é quem está ao lado.